

■ DATOS SINTÉTICOS - SOLO PARA PRUEBAS - NO ES PACIENTE REAL ■

Este documento fue generado automáticamente para el desarrollo del clinical-extractor de SICA. No contiene PHI ni representa una paciente real. Cualquier semejanza con un caso clínico real es coincidencia.

## HISTORIA CLÍNICA OBSTÉTRICA — CONTROL PRENATAL

Centro Materno Infantil Tahuantinsuyo Bajo (sintético) — Consultorio Obstetricia

### FILIACIÓN

|                 |                                            |
|-----------------|--------------------------------------------|
| Nombre:         | Lucía Mendoza Quispe (SINTÉTICA - NO REAL) |
| DNI:            | 47812936                                   |
| HC:             | HCL-2024-08847                             |
| Edad:           | 28 años                                    |
| Fecha consulta: | 10/06/2024                                 |

### ANTECEDENTES (referidos del control previo de sem 16)

Fórmula obstétrica: G2 P1 (parto vaginal 2019, RN 3,200 g sin complicaciones). Antecedente familiar materno de DM2 (madre dx a los 50 años). Sobrepeso pre-gestacional (IMC 25.6). Control previo realizado el 15/04/2024 por Dr. Vásquez con plan de PTOG en sem 24.

### GESTACIÓN ACTUAL

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| FUR:                  | 27/12/2023                        |
| FPP:                  | 03/10/2024                        |
| EG actual:            | 24 semanas + 1 día                |
| Controles prenatales: | 4 al momento                      |
| Movimientos fetales:  | Percibidos por la madre, normales |

### EXAMEN FÍSICO ACTUAL

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| Peso actual: | 71.2 kg (ganancia total 7.2 kg) |
| PA:          | 118/74 mmHg                     |
| FC:          | 82 lpm                          |
| AU:          | 24 cm (concordante con EG)      |
| FCF:         | 148 lpm                         |
| Edemas:      | Ausentes                        |

### LABORATORIOS DE ESTE CONTROL

| Analito          | Resultado | Unidad | Observación                          |
|------------------|-----------|--------|--------------------------------------|
| Hemoglobina      | 11.2      | g/dL   | Leve descenso esperado               |
| Urocultivo       | Negativo  | —      | Sin crecimiento                      |
| PTOG 75g — basal | 98        | mg/dL  | Normal (<92 normal, 92-125 alterado) |
| PTOG 75g — 1 h   | 178       | mg/dL  | Casi al límite (criterio >180)       |
| PTOG 75g — 2 h   | 162       | mg/dL  | ALTERADO (criterio >153)             |

### ECOGRAFÍA MORFOLÓGICA (sem 22)

Feto único en presentación cefálica. Peso fetal estimado 580 g (percentil 50). Anatomía sistemática: SIN malformaciones estructurales evidentes. Placenta corporal anterior, grado 0. Líquido amniótico: ILA 14 cm (normal). Doppler arteria uterina: índice de pulsatilidad dentro de percentiles normales.

### DIAGNÓSTICO

1. Embarazo de 24 semanas. 2. **\*\*DIABETES GESTACIONAL\*\*** (criterio IADPSG/ADA cumplido: valor 2 h post-carga 162 mg/dL > 153 mg/dL). 3. Sobrepeso pre-gestacional persistente.

## **PLAN**

1. **\*\*Interconsulta a Endocrinología\*\*** para evaluación y conducta. 2. **\*\*Interconsulta a Nutrición\*\*** para plan alimentario individualizado. 3. Inicio de **\*\*dieta para diabetes gestacional\*\***: 1800 kcal/día fraccionadas en 6 tomas (3 comidas + 3 colaciones), distribución 45% carbohidratos / 25% proteínas / 30% grasas. 4. **\*\*Automonitoreo de glicemias capilares\*\***: 4 controles diarios (basal + 1 hora post-prandial x 3 comidas principales). 5. Educación sobre signos de alarma de DG: hipoglucemia, hiperglucemia, cetonuria. Manejo emergencia diabética. 6. Continuar sulfato ferroso 60 mg/día + ácido fólico 5 mg/día. 7. Próximo control en 2 semanas (sem 26) para evaluar respuesta a dieta.

Médico tratante: Dr. Juan Carlos Vásquez Torres — CMP 45821

Documento generado para fines de prueba del clinical-extractor de SICA. Sintético. No representa una paciente real.